



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : عزيزه عبدالحليم جاد محمد

العنوان : بولاق الدكرور

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026

رقم البطاقة : 24911062700762 رقم التليفون : 01010152225

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-11-1949 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الأروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة الأبحاث والمرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: عزيزه عبدالحليم جاد محمد
National ID: 24911062700762



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ ومساءة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ ومساءة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيل الشخصية

عزیزہ
عبد الحلیم جاد محمد
٧١ سن عنی فایدہ ترعة زنین
بولاق الدكرور - الجیزہ

٢٤٩١١٠٦٢٧٠٠٧٦٢

JY4715226

٢٠٢٣/٠١/٠١ ٢٤٩١١٠٦٢٧٠٠٧٦٢

رہ منزل
مسلک
انشی

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠١/٠١

١

EL Azamia Lab

Prof. Abdalla Khalil
Pathology Lab



معمل الأعظمية

أ. د. عبدالله خليل
للتحاليل المرضية

Patient Name: عزيزة محمد عبدالحليم

Age: 74 Y.

Referred by Prof. Dr.: ا.د/ محمود بهاء

Nature of the Specimen: CORE BIOPSY

Clinical Diagnosis: RIGHT BREAST LESION

Receiving Date: Nov/ 2022

Code Number: G 32

PATHOLOGY REPORT

GROSS PATHOLOGY:

Multiple grey white and yellow tissue cores of total length 0.8 cm, totally submitted.

HISTOLOGY:

Serial sections examined revealed tissue cores infiltrated by malignant discohesive monotonous cells displayed as cords, files and individual cells, surrounded by desmoplastic stroma.

DIAGNOSIS:

INVASIVE LOBULAR CARCINOMA G2.

P.O.:

- 1) Detection of ER, PrR, Her-2 and Ki-67 is available on request.
- 2) Slide enclosed.

Laila Moussa

Prof. Dr. Laila Moussa, PhD

A.M. Khalil, MD

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

تاريخ الإصدار: 2022-12-21

جهة الإصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوتها ومنظمة للتأمين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس وقانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن العشرى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلية من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلية من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) عزيزه عبد الحليم جاد محمد بطاقة رقم 24911062700762
ودليقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتماء
يعتبر من الفئات غير المتفقه بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعة: 2022-12-21

الموظف المختص

امثال نعيم



مركز نظم المعلومات



مستمل 270982

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الإصدار

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



مبادرة رئيس الجمهورية
لحماية صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣

Name	عزيزه عبد الجبار جاد	MIRN	٥٠٠١ - ٥٥٥
Age	٦٤	ID	٥٤٩١١٠٦٤٧٠١٧٤
Menopausal status		Phone	٠١٠١٠٥٥٥٥
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:	ILC, G2	R	L
ER:	8/8	PR:	8/8
HER2:	(-ve)	Ki67:	40%
Sonomammography:	revision 15%		
Mets Workup:	PET/CT Scan → Pulmonary (lung mets)		
		TNM	

Recommendations:

after block revision
→ PR tx
HER -ve
Started femara, 2m 910.

MDT OUTCOME & PLAN

DEXA Scan - after pr, femara
after pr, femara
In proline bone sc scan

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. ياسر عبد الله د. مريم عبد الله		د. مريم عبد الله			

Name	Mrs. Aziza Abdulhaleem M. Mohamed	Date	20/06/20
Ref. by Prof. Dr.		Acc. No.	2006/20
ID	1122040590		

¹⁸F-FDG PET/CT Scan

Indication of the study: Status evaluation study for a case with previous history of right breast malignancy under investigation (as per se). No available previous study or pathological data.

Total body PET scan was done 40 minutes after IV administration of 300 MBq of ¹⁸F-FDG.

CT scanning was performed simultaneously without IV contrast material injection.

Semi-quantitative analysis would be done for selected ROIs & the normal threshold would be the normal blood pool liver SUV_{max} < 2.

Performed by:

Dr. Ismail Abdulhaleem, D.O.

Approved by:

Prof. Dr.

Essam El Sheikh

Head & Neck:

- Normal physiological biodistribution over scanned portion of the brain (N.B; not all brain metastatic deposits could be detected on ¹⁸F-FDG PET/CT due to physiologic uptake in brain; MRI brain is suggested in cases of clinical suspicion).
- Normal naso-oro-pharynx, larynx and salivary glands.
- *Non homogenous thyroid gland, for further work up.*
- No PET/CT abnormal (enlarged FOC hypermetabolic) cervical L_{4/5} seen.

Torso:

Thorax:

- *Right breast outer domain area of faint activity, measuring ± 2 cm eliciting SUV_{max} 2.5.*
- *Small low activity right axillary lymph nodes, largest ± 1.2 cm eliciting SUV_{max} 2.2.*
- *Bilateral pulmonary predominantly lower lobes low activity nodules, largest ± 1.2 cm eliciting SUV_{max} 2.*
- *Small metabolically active prevascular lymph node ± 1.2 cm eliciting SUV_{max} 2.*
- *Increased cardiothoracic ratio, for echo-heart.*
- No pleural or pericardial effusion seen.
- *Bilateral elastofibroma dorsi.*
- *Hiatus hernia.*

Patient Name	: الأستاذة / عزيزة عبدالحامد جاد محمد	Request No	: 13008548
Patient No.	: 24911062700762	Request Date	: 31/12/2022
Path No.	: SR-1002/22	Verification Date	: 31/12/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 73 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA

Right breast mass

NATURE OF SPECIMEN

Revision of tru cut biopsy & IHC slides

GROSS EXAMINATION

One block.

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score: 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score: 8/8)
- Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

DIAGNOSIS

Right breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :

Invasive lobular carcinoma, Grade II .

ER: Positive (8/8)

PR: Positive (8/8)

HER2: Negative (score0)

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 29/01/2023 14:18:17

Page 1 of 2

Printed by : marwa mohamed yousse

Patient No. : 5001-2022 Request No : 13004107
 Patient Name : الأستاذة / عزيزة عبدالحليم جاد محمد Request Date : 05-10-2025 14:54
 Sex : Female Age: 75 Y Verification Date : 05-10-2025 16:23
 Financial Cate: جوسلاف روسي - نفقة الدولة Sample Type : Serum
 Department : Out Patient Test Status : Routine
 Referring Doc : Analyzers : Response920_Hermel

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
Serum Creatinine	1.3	mg/dL	0.4 - 1.2)
Calcium Ionized (Ca++)	1.24	mmol/l	1.10 - 1.30)
Urea	49.5	mg/dL	17.0 - 43.0)

Signature

Eman Hamdi

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department



مركز
السرطان
دار السلام
القاهرة

Patient Name: Nevein Zarif Sefein Guindy	Date : 08/02/2023
Exam : ultrasound TRANS VAGINAL	Age : 40 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 26114

Trans-vaginal ultrasound scanning revealed:-

Uterus:-

- AVF, bulky size uterus measuring about: 11x6x5cm in its long transverse & AP diameters respectively.
- The myometrium shows homogenous texture with no focal le.
- The endometrial line is 6mm.

Ovaries:-

Bilateral ovarian multilocular complex cystic and solid lesions .

The solid component shows no internal vascularity inside

The cystic component shows internal floating materials of different echo

the two cysts are seen close to other at the midline (kissing cysts)

the right ovarian cysts measures 10x7cm

the left ovarian cysts measures 7x7.5cm

No free fluid in the Douglas pouch.

Conclusion:

Bilateral ovarian multilocular complex cystic and solid lesions (orads 3) for MRI study

Signature Dr . Nermien El Hachimi

08/02/2023 10:21 AM

جمعية مسجد د. مصطفى محمود

Dr. Mostafa Mahmoud Mosque Society

المركز الطبي بالإعلام

وحدة الأشعة العادية وأشعة الثدي

Mammography & X - Ray unit

Patient Name Aziza ahalim

Study Date: 28/1/2022

Patient Sex: F

Study ID: mammo

Birth Date: 12:00:00 AM

Study Description:

MAMMOGRAPHIC EXAMINATION FOR BOTH BREASTS

REVEALED:

- The right breast is the seat of highly suspicious ill defined irregular mass, at the upper outer quadrant of the breast . No diffuse skin thickening or associated suspicious micro calcification visible.
- Ultrasonography for the right breast showed large area of hypo echoic architectural distortion in the right breast from 6 to 10 o'clock measured about 50x15 mm with vascularity .
- large pathologically enlarged right axillary tail lymph node .
- Normal left mammogram.
- Normal skin thickness and contour of the left breast.

OPINION:-

Picture is in favor of a suspicious mass in the right breast, for dynamic MRI and biopsy.

BIRADS 4c/5.

Best regards,

DR. Eman El Taweel .MD

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0 : Needs further investigations.

BIRADS 1: Normal findings.

BIRADS 2: Benign.

BIRADS 3: Probably benign.

BIRADS 4: A: mild Probability of malignancy

B: moderate Probability of malignancy

C: marked Probability of malignancy.

BIRADS 5: Malignant.

BIRADS 6: Proven pathologically malignant

Name	Mrs. Aziza Abdalhalaeem Gad Mohammad		
Ref. By Prof. Dr.			
ID	1122040590	Date	8/12/2022
		Acc. No.	230080490

18F-FDG PET/CT Scan

Indication of the study: Status evaluation study for a case with previous history of right breast malignancy under investigation (as per se). No available previous study or pathological data.

Total body PET scan was done 40 minutes after IV administration of 300 MBq of 18F-FDG.

CT scanning was performed simultaneously without IV contrast material injection.

Semi-quantitative analysis would be done for selected ROIs & the normal threshold would be the normal blood pool liver $SUV_{max} < 2$

Reported By:

Dr. Islam Aboulwafa, MD

Approved By:

Prof. Dr.

Essam El-Shiekh

Head & Neck:

- Normal physiological biodistribution over scanned portion of the brain (N.B; not all brain metastatic deposits could be detected on 18-FDG PET/CT due to physiologic uptake in brain. MRI brain is suggested in cases of clinical suspicion).
- Normal naso-pharynx, larynx and salivary glands.
- *Non homogenous thyroid gland; for further work up.*
- No PET/CT abnormal (enlarged FDG hypermetabolic) cervical L.Ns seen.

Torso:

Thorax:

- *Right breast outer domain area of faint activity, measuring ± 2 cm eliciting $SUV_{max} 2.5$.*
- *Small low activity right axillary lymph nodes, largest ± 1.2 cm of $SUV_{max} 2.2$.*
- *Bilateral pulmonary predominantly lower lobes low activity nodules, largest ± 1.2 cm eliciting $SUV_{max} 2$.*
- *Small metabolically active prevascular lymph node ± 1.2 cm of $SUV_{max} 2$.*
- *Increased cardiothoracic ratio; for echo-heart.*
- No pleural or pericardial effusion seen.
- *Bilateral elastofibroma dorsi.*
- *Hiatus hernia.*

Name	Mrs. Aziza Abdalhaleem Gad Mohammad		
Ref. By Prof. Dr.		Date	8/12/2022
ID	1122040590	Acc. No.	230080490

Abdomen & Pelvis:

- Average size of the liver with non-homogenous density, no FDG hypermetabolic focal lesions.
- No intra-/extra-hepatic biliary radicals dilatation.
- Normal appearance of spleen, pancreas, adrenals and pelvic organs.
- No PET/CT abnormal (enlarged FDG hypermetabolic) abdominal or pelvic L.Ns seen.
- Normal physiological biodistribution over the bowel (non-uniform uptake with no sizable masses, mostly non-specific colitis) & urinary tracts.

Surveyed skeleton:

- No tracer active lytic or sclerotic osseous lesions seen.
- *Scattered sclerotic non-metabolically active foci of the spine and pelvic bones mostly degenerative changes.*
- *Bilateral trochanteric bursitis.*

Opinion:

- Considering the provided data; right breast malignancy with nodal and pulmonary low activity metastatic deposits; for mammographic and histogenic correlation.
- Rest of the surveyed body is free from any other FDG hypermetabolic neoplastic lesions.

Thanks for your referral;

Dr. Ahmed Kandeel
MD Nuclear Medicine

Dr. Islam Aboulwafa, MD
Prof. Dr. Essam Ali El-Shiekh

Prof. Abdalla Khalil
Pathology Lab



معمل الأعظمية
أ. د. عبد الله خليل
التحليل الباثولوجية

Age: 74 Y.

2.1 محمود بهاء

人：

Z

2

2

F

 $\therefore$

71

...

३॥

92

2

• •

- 11

Leila Mousso

D

D



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي



Patient Name : الأستاذة / عزيزة عبدالحليم جاك محمد
Patient No. : 24911062700762
Path No. : SR-1002/22
Sex : Female
Age : 73 Y
Referreing Doc. :

Request No. : 13008548
Request Date : 22/12/2022
Verification Date : 31/12/2022
Financial Category : نفقة المرأة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA

Right breast mass

NATURE OF SPECIMEN

Revision of tru cut biopsy &IHC slides

GROSS EXAMINATION

One block .

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
- Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

DIAGNOSIS

Right breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :

Invasive lobular carcinoma, Grade II .

ER: Positive (8/8)

PR: Positive (8/8)

HER2 : Negative (score0)

Verified by :

dr.estraa magdy

Printing Date : 29/01/2023 14:18:17

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Prof. Abdalla Khalil
Pathology Lab



معمل الأعظمية
أ. د. عبد الله خليل
للتحليل الباثولوجية

Age: 74 Y.

Nature of the Specimen: CORE BIOPSY

Receiving Date: Nov/ 2022

Code Number: G 32

GROSS PATHOLOGY:

HISTOLOGY:

DIAGNOSIS:
INVASIVE LOBULAR CARCINOMA G2.

P.O.:

- 1) Detection of ER, PrR, Her-2 and Ki-67 is available on request.
- 2) Slide enclosed.

Laila Moussi

Prof. Dr. Laila Moussa, PhD

A.M. Khalil, MD

Prof. Abdalla Khalil
Pathology Lab



معمل الأعظمية
أ. د. عبد الله خليل
للتحليل البصري لوجية

Age: 74 Y.

ا.د. / احمد ابراهيم
Referred by Prof. Dr.:

Nature of the Specimen: ER, PR, Her-2 AND Ki-67.

Clinical Diagnosis: BREAST CANCER (CORE BIOPSY)

Code Number:

IMMUNOHISTOCHEMICAL REPORT

Sections were treated with monoclonal antibodies for:

ER, PR, Her-2 and Ki 67.

RESULTS:

Turnour cells showed:

- Strong positive staining for ER score 8/8.
- Strong positive staining for PR score 8/8.
- Equivocal over expression for Her-2 score 2, for FISH study.
- Average 40% positive nuclear staining for Ki-67.

P.O.:

4 slides enclosed.

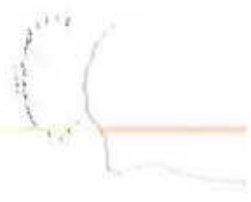
Laila Mousa
Prof. Dr. LAILA MOUSSA, PhD

Samira Abdellah
Prof. Dr. SAMIRA ABDALLAH, MD

A.M. Khaili, MD



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي



Patient Name الأستقاءة / عزيزة عبداللطيف جاد محمد
Patient No. 24911062700762
Path No. SR-1002/22
Sex Female
Age 73 Y
Referring Doc.

Request No. 13008548
Request Date 22/12/2022
Verification Date 31/12/2022
Financial Category أورام دالر السلام - نفقة الترقية
Department Out Patient

Registered by .marwa mohamed youssef

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Signature
Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr. Heba Hassan
Dr. Esraa Magdy

Verified by :
dr.esraa magdy

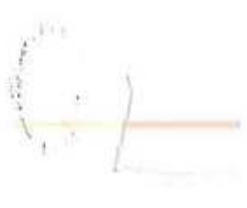
Printing Date : 29/01/2023 14:18:17

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youssef



Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي



Patient Name : الأستاذة / عزيزة عبد الحليم جاك محمد
Patient No. : 24911062700762
Path No. : SR-1002/22
Sex : Female
Age : 73 Y
Refereing Doc. :

Request No. : 13008548
Request Date : 22/12/2022
Verification Date : 31/12/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

CLINICAL DATA

Right breast mass

NATURE OF SPECIMEN

Revision of tru cut biopsy &IHC slides

GROSS EXAMINATION

One block .

Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis) : (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received
- * IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
- Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

DIAGNOSIS

Right breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :

Invasive lobular carcinoma, Grade II .

ER: Positive (8/8)

PR: Positive (8/8)

HER2 : Negative (score0)

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 29/01/2023 14:18:17

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse